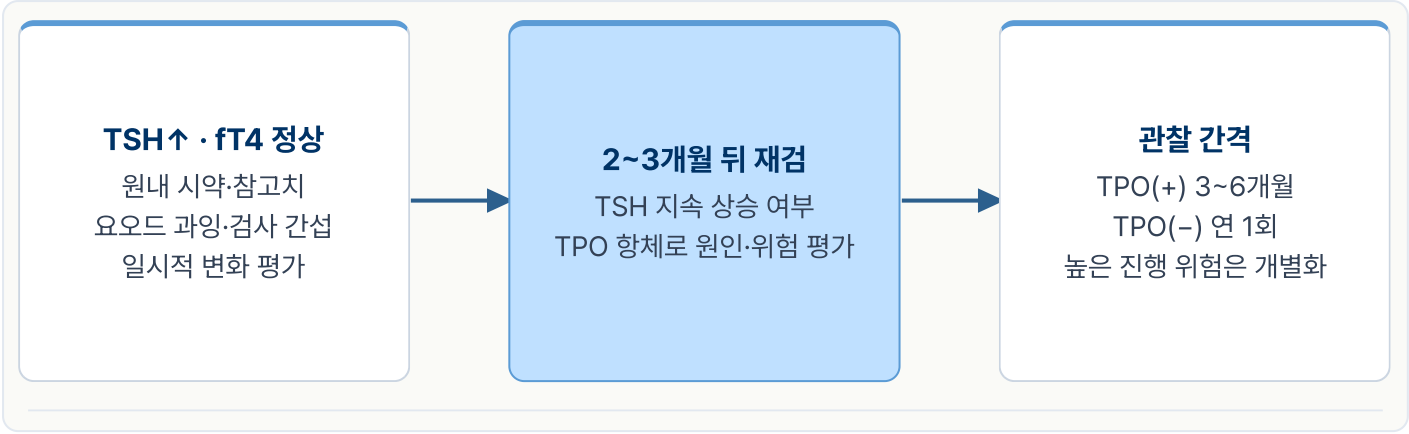
의료진 진료 카드 · ASL-051

무증상 갑상선기능저하증, 재검부터

fT4 정상 + TSH 상승. 측정 시약과 지속성, 연령을 함께 판단한다.

최초 이상과 지속적 이상을 구분한다



본강의 · 한국인과 시약별 참고치

한국인 분포	국건영 Roche 상한 6.86 mIU/L, 아산 검진 7.06, 영남대 남성 4.35·여성 6.42 mIU/L로 소개했다.
Roche 기준 분류	경증 6.8~10, 중증 >10 mIU/L. 시약에 따라 대응 기준이 달라 동일 기관·시약으로 추적한다. 참고범위와 치료 기준을 구분한다.

본강의 · 진행과 자연 회복

진행 위험	높은 TSH·정상 내 낮은 fT4, TPO 양성, 추적 TSH 2배 상승, 여성·갑상선염 병력 등을 본다.
경과 수치	Whickham 20년 추적 여성: 항체(+) 연 4.3%, (−) 2.6% 진행. 신규 SCH의 다른 자료는 연 5~8% 진행, 요오드 과잉 제한 후 약 30~35% 자연 회복으로 소개했다.

본강의 · 요오드와 항체

요오드 과잉	해조류·건강식품 등 과도한 섭취를 조절한다. 연자 Q&A는 하시모토에서 과잉 요오드가 기능저하를 유발할 수 있다고 설명했다.
항체	Anti-TPO·Anti-Tg는 자가면역의 마커이며 기능성 항체가 아니다. 기능이상 확인 뒤 원인 평가에 사용하며 양성 항체 역가를 반복 추적하는 방식은 피한다.

지속적 상승을 확인하고 치료를 결정한다. 연자는 TSH 약 20 이상에서는 재검보다 바로 치료하는 개인적 진료 경험도 설명했다.

의료진 진료 카드 · ASL-051

지속적 SCH, 치료와 관찰의 분기

연령 <70세 / ≥70세와 TSH 중증도를 함께 본다.

Roche 대응 기준의 치료 분기



교재 · 치료를 고려할 조건

진행 고위험	TSH >20 mIU/L, 갑상선엽절제 과거력, 만성갑상선염 병력 등은 LT4 치료 고려.
성인 중증 SCH	기저 관상동맥질환·심부전이 있으면 LT4 치료 권고, 이상지질혈증 개선 목적으로도 고려한다는 교재 각주.

교재 · 시약별 진단 대응값

Roche / Abbott	경증·중증 대응값: 6.8/10.0 · 5.2/7.7 mIU/L.
RiaKey / Brahms / Izotop	5.3/7.9 · 5.7/8.3 · 6.0/8.9 mIU/L.
Beckman-CLIA / Siemens / Beckman-RIA	6.5/9.7 · 6.9/10.2 · 7.4/10.8 mIU/L.

연자 Q&A · 이미 LT4를 복용 중이면

과거 TSH 5~6대·fT4 정상	TPO 양성/증상 때문에 시작했던 경우 환자와 상의해 서서히 감량·중단을 시도할 수 있다는 의견. 일반성인 치료 목표는 TSH 참고범위다.
갑상선 전절제 후 고령	미치료 SCH와 구분한다. TSH 정상 참고치의 높은 범위를 목표로 하고, 어렵다면 TSH <10을 제안했다.

35개 전향 코호트(555,530명, SCH 21,176명)의 사망 1.20(1.07~1.34)·심혈관사건 1.33(1.14~1.54)의 위험 연관성이 소개되었다. 이 연관성을 치료 효과 수치로 읽지 않는다.